

Examen du nouveau-né

- Cf vidéo « examen du nouveau-né » sur Moodle
- pour évaluer l'adaptation du nn
- examen systématique laisse passer qq h (min 6h), ds 1ères 24h de vie (sage-femmes, et pédiatre après 48h pour adaptation cardio-pulm soit mise en place)
- idéalement entre 2^e-5^e j
- évalue de la tête aux pieds
- cherche des anomalies congénitales, pour une PEC la plus précoce possible

	Examen sur le mannequin	A verbaliser et/ou faire verbaliser
Impression générale	Etat général, posture	tonus, mouvement, contact, trémulations
Etat d'éveil	Eveil calme, ouverture des yeux, ouverture des yeux	Etats d'éveil selon Brazelton, réaction au bruit, pleurs
Croissance	Croissance: P, T, PC (cf courbes)	
Visage		signes dysmorphiques? Asymétrie ? marques de naissance ? lésions ?
Peau	Inspection systématique	Eruption, marque de naissance ? ictère ? pléthorre ou anémie ? lésions ?
Crâne	Palpation du crâne, fontanelles, mesure du PC	Bosse séro-sanguine, céphalématome, sous-galéal ? Fracture ? chevauchement ? fusion précoce ?
Yeux	Pupilles, reflet (ophtalmoscope)	Mouvement des yeux ? Ecoulement ? Rougeur ?
Oreilles	Implantation, palpation du cartilage, forme	Appendice ? anomalie de forme ?
Bouche	Inspection et palpation	Fente ? Luvette ?
Cou	Inspection, palpation des SCM	Torticolis ? Web cutané ?
Clavicule	palpation	Touche de piano ?
Respiration	Points d'auscultation respiratoire	Signes de SDR ? (fréquence 40-60 ? Tirage ? BAN ? Grunting ? Cyanose ?)
Coeur	Palpation du choc de pointe ? Points d'auscultation cardiaque : Valve mitrale : apex, 5eIC sur la ligne mi claviculaire Valve tricuspide bord sternal inf G, 4-5e EIC Valve pulmonaire: parasternal gauche 2e EIC Valve aortique: parasternal D, 2e EIC	souffle ? FC 100-160/' ?
Abdomen	Palpation, auscultation	BD, foie, rate, reins, masse, ombilic, anus
Pulsations fémorales	Points de palpation, repères anatomiques	
OGE	Inspection, (Anatomie normale ?), palpation des testis chez le garçon	
Dos	Palpation de la colonne	Spina bifida, fossette, scoliose ?
Reflexes archaïques		Moro, marche, grasping, Gallant, escrimeur, points cardinaux, succion
Tonus	tronc, membres	Décrire comment évaluer le tonus passif
ROT	Pratique des ROT	
Membres	Symétrie, déformation	Déformations ? traumatismes obstétricaux ?
Mains, pieds	doigts, pli	
Hanches	Abduction ? <i>La manœuvre d'Ortolani/Barlow n'est pas possible sur le mannequin.</i>	Manœuvre d'Ortolani

Tableau 1 Status clinique du nouveau-né sur mannequin

1) bb doit être nu

2) état d'éveil

- éveillé sans être agité/hurler/être endormi

3) parents

- moment crucial pour eux (stressés)
- faire des gestes doux
- expliquer ce qu'on fait/va faire

4) paramètres de croissance

- taille, poids, périmètre crânien (jusqu'à 3 ans)
- place sur courbes pour détecter le couloir de cr
- PC : prit sur bosse frontale et occipitale

5) examiner tous les systèmes

a. impression générale (état d'éveil, comportement quand fait R) : ac échelle de Brazelton

- i. position état N : un peu en flexion
- ii. mouv très réflex au début
- iii. mouv spontané des yeux

b. crâne/tête

- i. sutures : N d'avoir des chevauchements les 1ers j
- ii. fontanelles : palper, devant (grand losange) et derrière (plus petit triangle), doivent être normotendues (pas déprimées ou bombées)
- iii. oreilles : forme, appendice, fistules, position (N bord sup oreille suit le coin de l'œil), otoscope : CAE ddc (N que petit et poilu mais devrait quand même pouvoir voir le tympan)
- iv. visage : signes dysmorphiques (forme/écartement yeux, forme/position oreilles, philtrum, forme nez et bouche, forme maxillaires (pommettes))
- v. pupilles (lampe de poche) : illuminer 1 côté à la fois pour voir le réflexe, puis les 2 pour voir si reflet symétrique (si strabisme vers l'int et se remet = N car fixation immature chez nn)
- vi. ophtalmoscope pour reflet rétinien (N rouge, le met env à 10cm), blanc = leucocorie (indique que possible masse p.e. rétinoblastome)
- vii. poursuite oculaire : cible env à 25cm de distance
- viii. bouche : langue, gencives, palais (fentes ! doit regarder jusqu'à la luvette)

c. peau

- i. tâches
- ii. angiomes plans (souvent au nx nuque, front), s'estompent
- iii. temps de recoloration (doigts, orteils)
- iv. chaleur (marbrures, peau rosée)
- v. ictère

d. réflexes archaïques (partent vers 3-5 mois)

- i. succion : mettre bout petit doigt ds bouche
- ii. frotter bouche de côté et doit venir chercher pour sucer
- iii. mains : grasping (appuie sur paumes ou plantes et serrent doigts/orteils)

- iv. pieds : Babinski (chez nn : N d'avoir une extension)
- v. marche automatique : prend sous aisselles, frotte côté pied contre table et marche automatique
- vi. galant (contraction du côté ou tapote quand placé sur le ventre ac main dessous)
- vii. Moro (écarte les bras puis les fléchit quand lâche)
- e. cardio-pulmonaire (resp plus rapide et irrégulière N, FC 120-160 bat/min)
 - i. auscultation cardio-pulm
 - ii. pouls fémoraux (si bondissant : signe coarctation d'aorte)
 - iii. chercher signes de détresse resp (tirage intercostal/sus et sous-sternal, battement ailes du nez, balancement thoraco-abdominal)
- f. abdominal
 - i. auscultation
 - ii. palpation superficielle et profonde (palper foie, rate)
 - iii. cordon
 - iv. tirer-assis (va essayer de mobiliser la tête quand le tire vers le haut), teste le tonus axial
- g. organes génitaux
 - i. garçon : forme pénis, testicules ds bourses
 - ii. fille : écarter un peu les grandes lèvres pour voir les petites
 - iii. anus : perforé, bien placé, pertuis
- h. palper clavicules : cherche fractures, ressaut, douleur
- i. palper membres
 - i. voit le tonus périphérique quand bougent
 - ii. voit aussi le tonus des membres ac signe de l'écharpe (doit avoir un peu de résistance quand tire un bras vers l'autre épaule)
- j. réflexes (bicipital, rotulien) : bons chez nn
- k. dos : touffe de poils, spina bifida
 - i. regarder comportement quand est sur le dos
 - ii. tâches mongoloïdes : bleutés, chez pers à peau foncée
- l. pieds, mains : nbre de doigts/orteils
- m. hanche : cherche signes de dysplasie congénitale de la hanche (tête fémorale mal ds le condyle)
 - i. Ortolani : index sur art, tient jambes à 90°, les amène vers l'ext, si ressaut : signe de dysplasie
 - ii. Barlow : jambes à 90° et appuye vers bas, dysplasie si ressaut
- n. ss

ARC Pédiatrique

- consultation mère et enfant
- cas : douleur abdominale chez un enfant de 4 ans (constipation)
- va développer le DD ensemble et trouver le dx principal ensemble

Consultation pédiatrique

- structure selon Calgary-Cambridge (schéma), schéma 2021 : child-centered-consultation CCC
- reconnaître les questions et les craintes de l'enfant et de l'entourage (ICE = ideas, concerns, expectations)
- double source d'info: patient & parent